

ENCAPS / SERUMS 2026-II

Salud Publica I-3 - Vigilancia Epidemiologica

20 preguntas con solucionario

Intente responder antes de leer la solucion. Claves verificadas contra la Directiva Sanitaria 046-MINSA/DGE-V.01 (RM 506-2012), la Directiva Administrativa 341-MINSA/CDC-2023 (RENACE) y los compendios de Salud Publica.

1. En una comunidad dispersa de Loreto, los Agentes Comunitarios de Salud (ACS) capacitados reportan al EESS los casos de fiebre y diarrea que detectan entre sus vecinos, antes de que acudan al establecimiento. ¿Qué tipo de vigilancia es?

- A) Centinela
- > B) Comunitaria**
- C) Pasiva
- D) Sindrómica

RESPUESTA: B

COMUNITARIA: la detección la hace la propia comunidad organizada (ACS, promotores, parteras), no el personal de salud. Clave en zonas dispersas donde la demanda espontánea subregistra. TRAMPA: no es 'activa' porque no sale el equipo de salud; no es 'pasiva' porque no espera la consulta.

Fuente: MOPECE/OPS; Compendio SP 2026-II - tipos de vigilancia

2. La DIRESA designa 5 hospitales con laboratorio para monitorear la tendencia estacional de influenza, sin pretender captar todos los casos de la región. ¿Qué tipo de vigilancia aplica?

- A) Activa
- B) Universal
- > C) Centinela**
- D) Comunitaria

RESPUESTA: C

CENTINELA: pocos EESS seleccionados, con capacidad diagnóstica, para estimar TENDENCIAS - no la magnitud total. Su límite: no da incidencia poblacional real. Su ventaja: barata y sostenible.

Fuente: MOPECE/OPS; Compendio SP 2026-II

3. Ante un aumento de casos febriles sin diagnóstico confirmado, el EESS notifica el 'síndrome febril icterico' para gatillar la respuesta sin esperar el laboratorio. Esta modalidad de alerta-respuesta se rige por:

- > A) Directiva 065-MINSA/OGE-V.01 (RM 581-2005), Vigilancia Sindrómica**
- B) Directiva 046-MINSA/DGE (RM 506-2012)
- C) Directiva 341-MINSA/CDC-2023 (RENACE)
- D) NTS 078-2009 Vigilancia Perinatal

RESPUESTA: A

La vigilancia sindrómica (alerta-respuesta) la norma la Dir. 065-MINSA/OGE-V.01, RM 581-2005. Vigila SÍNDROMES (no diagnósticos) para ganar tiempo. OJO: la 065 NO es 'los 12 pasos de investigación de brote' - ese es un error frecuente de apuntes.

Fuente: Directiva 065-MINSA/OGE-V.01 (RM 581-2005)

4. Tras notificarse un caso de sarampión, el equipo del EESS realiza barrido casa por casa en 5 manzanas buscando febriles con exantema no notificados. ¿Qué está ejecutando?

- A) Vigilancia pasiva reforzada
- > B) Búsqueda activa comunitaria
- C) Vigilancia centinela
- D) Notificación negativa

RESPUESTA: B

BÚSQUEDA ACTIVA (vigilancia activa): el equipo SALE a buscar casos no captados. Obligatoria ante enfermedades en eliminación. Regla única del sub-tema: ¿el sistema va a buscar? -> ACTIVA, sea en domicilios, archivos o laboratorio.

Fuente: MOPECE/OPS; Dir. 046 (medidas ante caso probable)

5. El personal de salud ambiental inspecciona viviendas y calcula el índice aélico, sin registrar casos humanos. Esta vigilancia es de tipo:

- A) Comunitaria
- B) Sindrómica
- > C) Entomológica (del vector)
- D) Centinela

RESPUESTA: C

ENTOMOLÓGICA: vigila al VECTOR, no a la persona. Gatillo: si el enunciado habla de índice aélico/larvario, ovitrampas o inspección de viviendas y NO hay caso humano -> entomológica. Base para decidir el control vectorial antes del brote.

Fuente: Mapa QX 'Vigilancia entomológica de dengue'; Dir. 037-MINSA/DGE (RM 658-2010)

6. En un comedor comunal de Ucayali, de 80 personas que consumieron el guiso, 24 enfermaron en 10 horas. ¿Cuál es la tasa de ataque?

- > A) 30%
- B) 24%
- C) 3.3%
- D) 80%

RESPUESTA: A

TASA DE ATAQUE = enfermos / EXPUESTOS x100 = 24/80 = 30%. El denominador NUNCA es la población del distrito: son solo los expuestos. Sirve para hallar el vehículo: el alimento con la tasa de ataque más alta es el sospechoso.

Fuente: Compendio SP 2026-II (López) pág. 3 - indicadores; MOPECE

7. En un distrito de 20 000 habitantes ocurren 10 muertes por neumonía en el año. ¿Qué indicador expresa el impacto de esas muertes en TODA la comunidad, y cuánto vale?

- A) Letalidad, 10%
- > B) Tasa de mortalidad, 50 por 100 000
- C) Tasa de ataque, 0.05%
- D) Prevalencia, 10 casos

RESPUESTA: B

MORTALIDAD = muertes / POBLACIÓN TOTAL = $10/20\,000 \times 100\,000 = 50$ por 100 000. Mide el impacto en la comunidad entera. Contraste: letalidad = muertes / ENFERMOS (qué tan mortal es en quien ya la tiene). EL DENOMINADOR DEFINE EL NOMBRE.

Fuente: Compendio SP 2026-II pág. 3; Theomed Manual SP

8. En una comunidad de 5 000 personas hay actualmente 250 personas con hipertensión diagnosticada. ¿Qué indicador es y cuánto vale?

- A) Incidencia, 5%
- > B) Prevalencia, 5%
- C) Tasa de ataque, 5%
- D) Letalidad, 5%

RESPUESTA: B

PREVALENCIA = casos EXISTENTES (nuevos + antiguos) / población = $250/5000 = 5\%$. Gatillo: 'actualmente', 'en total', 'viven con' -> prevalencia. 'Nuevos', 'aparecieron este año' -> incidencia. En crónicas como HTA la prevalencia es alta porque los casos no se curan.

Fuente: Compendio SP 2026-II pág. 3 - medidas de frecuencia

9. En un brote, el número reproductivo efectivo (R_t) cae a 0.7 tras la intervención. ¿Qué significa?

- A) La epidemia sigue creciendo
- B) La epidemia se mantiene estable
- > C) La epidemia está en descenso y tenderá a extinguirse
- D) No puede interpretarse sin conocer la letalidad

RESPUESTA: C

$R_t < 1$ -> cada caso genera menos de un caso nuevo -> la transmisión DECRECE y el brote se extingue. $R_t = 1$ se mantiene; $R_t > 1$ crece. Diferencia con R_0 : el R_0 asume población TOTALMENTE susceptible; el R_t es el real, ya con vacunación e intervenciones.

Fuente: Theomed Manual de Salud Pública - indicadores de riesgo en brotes

10. Fallece una gestante de 30 años por eclampsia en un EESS I-4. Además de la notificación, ¿qué norma específica rige la vigilancia de este evento?

- > A) Directiva 036-MINSA/DGE-V.01 (RM 634-2010), vigilancia de muerte materna**
- B) Directiva 047-MINSA/DGE (RM 545-2012), brotes
- C) NTS 078-2009, vigilancia perinatal y neonatal
- D) Reglamento Sanitario Internacional 2005

RESPUESTA: A

La muerte materna tiene directiva propia: Dir. 036-MINSA/DGE-V.01 (RM 634-2010), que establece notificación E INVESTIGACIÓN. Figura en la base legal de la 046. Regla mayor: cuando un evento tiene norma específica, esa manda sobre la genérica (igual que dengue -> Dir. 037).

Fuente: Dir. 046 (RM 506-2012), Base Legal pág. 14 - cita expresa de la RM 634-2010

11. De los siguientes eventos, ¿cuál se notifica de forma CONSOLIDADA y no individual?

- A) Tuberculosis pulmonar
- B) Sarampión
- > C) Enfermedad diarreica aguda (EDA)**
- D) Muerte materna

RESPUESTA: C

Las CONSOLIDADAS son un grupo corto: EDAS, IRAS/neumonías/SOB-asma e IIH - eventos de alta frecuencia que se reportan por conteo agregado. TODO LO DEMÁS ES INDIVIDUAL. TRAMPA: TB es individual y semanal; sarampión individual e inmediata.

Fuente: Dir. 046 (RM 506-2012), Anexo 01 - columna 'tipo de notificación'

12. Una unidad notificante deja de enviar reportes durante 4 semanas seguidas, sin que se sepa si hubo o no casos. ¿Cómo se denomina esta situación?

- A) Notificación negativa
- > B) Silencio epidemiológico**
- C) Subregistro pasivo
- D) Cierre de base de datos

RESPUESTA: B

SILENCIO EPIDEMIOLÓGICO = la unidad deja de reportar y el sistema no distingue 'no hubo casos' de 'no notificaron'. Indicador de mala calidad del sistema. Se previene con la notificación NEGATIVA (reportar el cero). Son conceptos OPUESTOS: la negativa es la solución, el silencio el problema.

Fuente: Dir. Adm. 341-MINSA/CDC-2023, 5.1.h (notificación negativa)

13. Un paciente convivió con un enfermo de tos ferina confirmado por laboratorio y presenta tos paroxística. No se le tomó muestra. Según la Directiva 046, ¿cómo se clasifica?

- A) Caso sospechoso
- B) Caso probable
- > C) Caso confirmado por nexo epidemiológico**
- D) Caso descartado

RESPUESTA: C

DATO DE ALTA TRAMPA: el nexo epidemiológico es criterio de CONFIRMACIÓN, no de 'probable'. La 046 lo define textual: persona que tuvo contacto con enfermos o forma parte de una cadena de transmisión 'donde se ha confirmado al menos un caso por laboratorio'. Aquí SÍ hay un confirmado en la cadena -> confirmado por nexo, sin muestra propia.

Fuente: Dir. 046 (RM 506-2012), 5.1 Definiciones operativas pág. 15 - texto literal

14. Un caso notificado como sospechoso de dengue resulta con IgM negativa y se documenta otro diagnóstico. ¿Cómo queda clasificado?

- A) Caso probable
- > B) Caso descartado**
- C) Caso confirmado
- D) Se mantiene sospechoso hasta el cierre anual

RESPUESTA: B

CASO DESCARTADO: la 046 lo define como 'todo caso sospechoso o probable con evidencia clínica, de laboratorio o antecedente epidemiológico que permite descartar' la enfermedad. El caso NO desaparece del sistema: se reclasifica. Esa reclasificación es parte del cierre de base de datos, que es ANUAL.

Fuente: Dir. 046 (RM 506-2012), 5.1 Definiciones operativas pág. 15

15. En Lima se registra un caso de malaria en un paciente que estuvo dos semanas en Loreto y no salió de Lima antes ni después. Según la Directiva 046, el caso es:

- A) Autóctono
- > B) Importado**
- C) Confirmado por nexo epidemiológico
- D) Sospechoso

RESPUESTA: B

IMPORTADO: la 046 define que es todo caso cuyo LUGAR PROBABLE DE INFECCIÓN es DIFERENTE a la jurisdicción que lo registra. Aquí se infectó en Loreto y se registra en Lima. Contraste: AUTÓCTONO = lugar probable de infección en la MISMA jurisdicción. Distinguirlos define si HAY TRANSMISIÓN LOCAL - y de eso depende la respuesta.

Fuente: Dir. 046 (RM 506-2012), 5.1 Definiciones operativas pág. 15

16. En un colegio se detectan 3 casos de parotiditis en la misma aula en 10 días, agrupados en tiempo y espacio, aún en investigación. ¿Cómo se denomina esta agrupación?

- A) Pandemia
- > B) Conglomerado (cluster)**
- C) Endemia
- D) Caso índice

RESPUESTA: B

CONGLOMERADO = agrupación de casos en tiempo y espacio cuyo número puede o no superar lo esperado - está EN INVESTIGACIÓN. Si se confirma que excede lo esperado, se declara BROTE. Secuencia: conglomerado (sospecha) -> confirmas contra lo esperado -> brote.

Fuente: MOPECE/OPS; Compendio SP 2026-II pág. 10

17. Una enfermedad transmisible se propaga simultáneamente en varios continentes con transmisión comunitaria sostenida. ¿Qué escala corresponde?

- A) Epidemia
- > B) Pandemia**
- C) Endemia elevada
- D) Brote multinacional

RESPUESTA: B

PANDEMIA: epidemia que cruza fronteras y afecta varios continentes, con transmisión sostenida. La diferencia con epidemia NO es la gravedad ni el número de muertos: es la EXTENSIÓN GEOGRÁFICA. Escalera: caso -> conglomerado -> brote -> epidemia -> pandemia.

Fuente: MOPECE/OPS; Compendio SP 2026-II pág. 10

18. Según la Directiva Administrativa 341-MINSA/CDC-2023, el nivel LOCAL de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) está constituido por:

- A) El Centro Nacional de Epidemiología (CDC)
- B) Las DIRESA / GERESA / DIRIS
- > C) Las unidades notificantes (establecimientos de salud)**
- D) Las Redes Integradas de Salud (RIS)

RESPUESTA: C

El nivel LOCAL = la unidad notificante, es decir el ESTABLECIMIENTO DE SALUD: ahí nace el dato. Arquitectura de 4 niveles: Local (unidad notificante) -> Intermedio (Red/DISA) -> Regional (DIRESA/GERESA/DIRIS) -> Nacional (CDC). Flujo ASCENDENTE: si el dato no nace en el EESS, el sistema no existe.

Fuente: Dir. Adm. 341-MINSA/CDC-2023 - organización y funcionamiento del RENACE

19. En un brote de tuberculosis en un penal, el mecanismo por el cual el bacilo abandona al enfermo al toser corresponde a:

- A) Puerta de entrada
- > B) Puerta de salida**
- C) Reservorio
- D) Vía de transmisión

RESPUESTA: B

PUERTA DE SALIDA = por dónde el agente ABANDONA al reservorio (aquí, la vía respiratoria al toser). Cadena de 6 eslabones: agente -> reservorio -> puerta de SALIDA -> vía de transmisión -> puerta de ENTRADA -> huésped susceptible. En TB salida y entrada son respiratorias: por eso se corta con mascarilla y ventilación.

Fuente: Compendio SP 2026-II pág. 13 - cadena epidemiológica (6 eslabones); Theomed

20. El boletín epidemiológico semanal que la DIRESA envía a los EESS con el análisis de la semana corresponde a qué etapa del proceso de vigilancia?

- A) Recolección
- B) Análisis
- > C) Difusión**
- D) Intervención

RESPUESTA: C

DIFUSIÓN: la 046 la define como el 'proceso final de la vigilancia epidemiológica y/o publicación de la información elaborada'. Es el eslabón que se olvida: sin difusión el dato no llega a quien decide. Ciclo: recolección -> análisis e interpretación -> DIFUSIÓN -> intervención.

Fuente: Dir. 046 (RM 506-2012), 5.1 Definiciones operativas pág. 15 - 'Difusión'